

## 胆道癌 chemo パス(4泊5日) 解説

質問がある場合は担当スタッフもしくはスーパーバイザーまでお願い致します。

### 【対象】

・本パスは、**切除不能胆道癌に対する初回化学療法導入**を対象としています。

以下のレジメンはすべて本パスで対応可能です：

- ① GC+Durvalumab 療法（ゲムシタビン+シスプラチン+デュルバルマブ）
- ② GCP 療法（ゲムシタビン+シスプラチン+ペムブロリズマブ）
- ③ GC 療法（ゲムシタビン+シスプラチン）
- ④ GS 療法（ゲムシタビン+S-1）
- ⑤ GEM 単剤療法

### 【背景】

- ・2010年に切除不能胆道癌に対する GEM 単剤と GC 療法のランダム化第 III 相試験(ABC-02 試験)<sup>1</sup>の結果が報告され、GEM 単剤に対する GC 療法の全生存期間の優越性が示されたことから、GC 療法が標準治療として確立されました。以降、長らく国内外で広く用いられてきました。
- ・2019年には切除不能胆道癌に対する GC 療法と GS 療法を比較したランダム化第 III 相試験（FUGA-BT 試験）<sup>2</sup>により GC 療法に対する GS 療法の非劣勢が示されました。
- ・近年では、免疫チェックポイント阻害薬（ICI）の登場に伴い、GC+Durvalumab 療法の GC+プラセボに対する優越性を示した国際共同ランダム化第 III 相試験(TOPAZ-1)<sup>3</sup>や、GCP 療法の GC+プラセボに対する優越性を示した（KEYNOTE-966）<sup>4</sup>の結果が示されました。最新の胆道癌診療ガイドライン（改訂第4版 2025）では、切除不能胆道癌に対する初回薬物療法として GC+Durvalumab 療法、GCP 療法が推奨されています。（推奨度 1、レベル A）<sup>5</sup>

### <参考文献>

1. Valle J, et al. ABC-02 Trial Investigators. Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for biliary tract cancer. N Engl J Med. 2010;362:1273-81.
2. Morizane C, et al. Combination gemcitabine plus S-1 versus gemcitabine plus cisplatin for advanced/recurrent biliary tract cancer: the FUGA-BT (JCOG1113) randomized phase III clinical trial. Ann Oncol. 2019;30:1950-1958.
3. Oh DY, et al. Durvalumab or placebo plus gemcitabine and cisplatin in participants with advanced biliary tract cancer (TOPAZ-1): updated overall survival from a randomised phase 3 study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2024;9:694-704.

4. Kelley RK, et al. KEYNOTE-966 Investigators. Pembrolizumab in combination with gemcitabine and cisplatin compared with gemcitabine and cisplatin alone for patients with advanced biliary tract cancer (KEYNOTE-966): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023;401:1853-1865.

#### 5. 胆道癌診療ガイドライン改訂第4版 2025

##### 【ICIについて】

- ・デュルバルマブ（イミフィンジ：抗PD-L1抗体）やペンブロリズマブ（キイトルーダ：抗PD-1抗体）はICIであり免疫関連有害事象（irAE：immune-related Adverse Events）を引き起こす可能性があります。irAEは非常に多彩で、定期的なホルモン採血やirAEを意識した診察（問診）が極めて重要です。
- ・胆道癌に対して保険適応がある上記2剤の使い分けに関して、現時点で明確に定まったものはありません（両者を直接比較した試験は現時点では実施されていません）。
- ・PD-1受容体のリガンドにはPD-L1とPD-L2があるため、デュルバルマブはPD-L1作用のみであるのに対してペンブロリズマブはPD-L1、L2の両方の作用があり、強い抗腫瘍効果が得られる可能性がある反面、強い副作用が出現する可能性が示唆されています。このため当院では原則として現在65歳までの患者さんにはGCP療法を、66歳以上の患者さんにはGC+Durvalumab療法を選択しています。

##### 【整腸剤の併用について】

- ・ICIの臨床効果は腸内細菌叢に影響されるという報告が近年発表されました。腸内細菌叢は腸の恒常性を維持するのに不可欠だけでなく、複雑なネットワークを介して全身の免疫系を調整しており、腸内細菌叢は毒素や代謝産物、パターン認識受容体などを介してがんの発症および進行に影響することが報告されています<sup>6</sup>。さらに、抗菌薬を使用していなかった患者群と比較して抗菌薬を使用していた患者群では生存期間が有意に短かったことがメタ解析によって報告されています<sup>7,8</sup>。
- ・腎がんを対象とした検討では、ICI治療において整腸剤試験薬（ミヤBMの類似薬）を投与した群と投与していない群の比較で、投与した群では有意に全生存期間と奏効率が良好であったことが報告されました<sup>9</sup>。
- ・当院では、上記の報告結果を受けて原則として全例にミヤBM錠を投与する方針としています。またICI治療中の胆道癌の患者さんには予防的な抗生剤の投与を控える方針としています。

##### <参考文献>

6. 安達圭志ら：がんに対する免疫チェックポイント阻害療法と関連する腸内細菌叢. 腸内細菌学雑誌. 2021;351:43-145.

7. Crespín A, et al. A systematic review and meta-analysis evaluating the impact of antibiotic use on the clinical outcomes of cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors. *Front Oncol.* 2023;13:1075593.
8. 南島拓矢ら, 免疫チェックポイント阻害薬の有効性および安全性に対する抗菌薬使用の影響. *医療薬学.* 2022;48:173-193.
9. Dizman N, et al. Nivolumab plus ipilimumab with or without live bacterial supplementation in metastatic renal cell carcinoma: a randomized phase 1 trial. *Nat Med.* 2022;28:704-712.